

15 - 07- Les Psychothérapies - Pr. Manoudi

(0:00 - 0:22)

Un malade, il peut avoir une très bonne alliance thérapeutique avec son médecin généraliste qu'avec son psychiatre. Donc, il va demander d'avoir une psychothérapie pas avec son médecin généraliste qu'avec son psychiatre. Donc, cette alliance thérapeutique, elle joue un rôle très important dans l'amélioration des patients.

(0:22 - 1:03)

30 % d'amélioration avant même de prendre le médicament, elle est due à cette alliance thérapeutique. Et des fois, vous le constatez vous-même quand vous accompagnez vos parents, bien un membre de la famille chez le médecin, une fois qu'il sort de chez le médecin, avant même de passer à la pharmacie, il vous dit « je me sens mieux, ce n'est pas urgent, ce n'est pas la peine d'aller directement à la pharmacie, on rentre à la maison, on verra après ». Un tiers de l'amélioration, elle est due à cette relation. C'est une thérapie qui utilise des moyens psychologiques, que ce soit les relations verbales, l'expression artistique, les relaxations.

(1:03 - 1:19)

Les méthodes sont codifiées. À part la psychothérapie, même dans la psychothérapie de soutien, il y a un art, il y a un savoir-faire et un savoir-être pour bien la faire. Mais les autres types de psychothérapie qu'on va voir, ce sont des psychothérapies codifiées.

(1:19 - 1:30)

Ça veut dire qu'ils ont tous des règles à respecter. Ils ont tous des indications et on a une méthode pour les faire. Il faut faire des formations pour pouvoir les faire.

(1:31 - 1:41)

Il y a des formations qui durent une année, il y a des formations qui durent deux ans. Ils se fondent sur la relation médecin-malade. Ça, c'est très important.

(1:41 - 2:00)

On peut utiliser soit des techniques individuelles, soit des techniques collectives. Il y a des patients chez qui on ne va utiliser que les techniques individuelles et il y a des patients chez qui on va utiliser les deux. Les psychothérapies individuelles, bien sûr, ça va de soi.

(2:00 - 2:07)

Vous reconnaissez la psychothérapie analytique, la psychanalyse. On ne fait pas de psychanalyse collective. La psychanalyse, c'est individuel.

(2:08 - 2:22)

La psychothérapie de soutien, en général, c'est individuel. Comme vous l'avez fait pour un patient déprimé, un patient anxieux, un patient schizophrène, un patient qui a un problème. Même médicament, même organique, un diabétique, un cancéreux.

(2:24 - 2:38)

Mais vous pouvez la faire en cas de grande catastrophe. Par exemple, dans le cas du séisme, vous pouvez faire une psychothérapie de soutien pour toute une famille, pour tout un groupe. Même pour un groupe des intervenants, par exemple.

(2:38 - 2:51)

On le fait pour les policiers, on le fait pour les ambulanciers, on le fait pour les secouristes. Ça, vous pouvez faire le soutien même en groupe des fois. Les thérapies cognitivo-comportementales, c'est des thérapies, on va voir comment ça agit.

(2:51 - 3:17)

Vous allez avoir une idée générale, mais pour être cognitivo-comportementaliste, il faut faire le diplôme de TCC qui dure deux ans. Donc là, les thérapies cognitivo-comportementales, on va agir sur les cognitions du patient et sur les comportements du patient. On peut aussi le faire en collectif, on va voir dans quel cas.

(3:17 - 3:35)

Les thérapies à médiation corporelle, c'est des thérapies avec des scènes de théâtre qui utilisent le corps pour exprimer une souffrance. Et puis, il y a l'hypnose, l'hypnothérapie. Parmi les thérapies collectives, il y a les psychothérapies de groupe.

(3:36 - 3:55)

On va citer les groupes des alcooliques anonymes, par exemple. Les psychothérapies familiales, soit les psychothérapies de couple, ou bien en cas de problème chez l'adolescent, on fait les psychothérapies de l'adolescent avec les parents. Les psychothérapies de couple, surtout dans les problèmes sexuels.

(3:55 - 4:33)

Les psychothérapies institutionnelles, c'est les groupes BALINT, c'est les groupes décrits par un psychiatre anglais. BALINT, c'est le groupe de thérapie qu'on fait dans les services où on fait des réunions institutionnelles. On ne va pas discuter les pathologies des patients, on va regrouper tout le personnel infirmier, le personnel médecin, les externes, où on va discuter le vécu de ce

personnel avec les patients, le relationnel de ce personnel avec le patient, les difficultés qu'a ce personnel dans le plan relationnel, sur le plan relationnel avec les patients.

(4:33 - 5:01)

Donc, on ne discute pas les problèmes de santé, mais on discute tout ce qui est relationnel. On discute le problème du personnel lui-même par rapport à la prise en charge des patients, c'est la difficulté, par rapport à l'engagement et par rapport à l'identification des patients. Parce qu'il y a des infirmiers, par exemple, qui sont dans les services de soins intensifs, les services d'oncologie, qui s'impliquent beaucoup avec un patient, qui s'identifient beaucoup au patient.

(5:02 - 5:16)

Un infirmier, ou bien un externe, ou bien un médecin, qui va prendre le patient, si c'est un patient âgé, comme son père, ou bien comme sa mère. Donc, il va s'identifier. C'est-à-dire, pour lui, ce patient, il lui représente sa mère ou son père.

(5:16 - 5:32)

Imaginez, après, le patient décède. Donc, il peut le faire pour le premier patient. Imaginez qu'il va le faire, et c'est des gens qui sont comme ça, qui s'investissent avec les patients et qui s'identifient aux patients, qui sont beaucoup dans la sympathie et l'empathie avec le patient.

(5:32 - 5:45)

Imaginez qu'il va le faire avec plusieurs patients. Donc, à la fin, il va tomber dans le burn-out. Donc, c'est des choses qu'on va discuter au cours de ces réunions, à l'avance, avant que le personnel tombe dans le burn-out.

(5:45 - 6:12)

La sociothérapie, c'est des thérapies qu'on fait à l'échelle de la société. C'est tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est insertion professionnelle des handicapés, pas uniquement les malades mentaux, mais les patients atteints, par exemple, d'épilepsie, qui reçoivent beaucoup de rejets par rapport à l'embauche. Alors, on va voir tous les types de psychothérapie brièvement.

(6:13 - 7:18)

La psychothérapie analytique, qu'on appelle aussi la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle vise, la psychanalyse ? De quoi il s'agit ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe, la psychanalyse ? Vous avez vu des films de psychanalyse ? Vous avez une idée de comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il fait le thérapeute ? Qu'est-ce qu'il fait le patient ? Psychanalyse, c'est un terme que vous avez déjà vu, vous connaissez ce que c'est. Dans les films, comment ça se passe ? Le patient, qu'est-ce qu'il fait ? Il

parle, voilà, et le thérapeute, il écoute. Le patient, il parle, et quand il parle, l'objectif, c'est de faire remonter des choses qui sont dans l'inconscient au niveau conscient, y faire face et les dépasser.

(7:19 - 7:38)

C'est qui qui fait l'effort dans ce jeu-là, dans ce type de thérapie ? Le patient qui fait l'effort, d'accord ? Dans les psychanalyses, les psychothérapies analytiques type, au début, en général, le thérapeute intervient peu. C'est le patient qui fait l'effort. Il commence à raconter, à parler de son histoire.

(7:38 - 7:50)

À un moment, il va faire remonter des choses qui sont dans l'inconscient vers le niveau conscient. Il les voit, il va pouvoir leur faire face et les dépasser. C'est comme ça qu'il va guérir.

(7:51 - 8:18)

Alors, qu'est-ce qu'il vise cette thérapie ? Il vise à ramener au niveau conscient les conflits intrapsychiques qui sont refoulés, à les affronter et puis à les dépasser. Ils ne vont plus rester dans un stade fixé où ils étaient initialement au niveau inconscient, mais ils vont bouger au niveau conscient et le sujet peut les dépasser. Alors, ils sont pratiqués par un psychanalyste.

(8:18 - 8:44)

Vous savez, un psychanalyste peut être médecin comme il peut être un psychologue qui a fait des études de psychanalyse. En général, les études durent cinq ans, que ce soit pour le médecin ou pour le psychologue. Après la fin de leur formation, le psychanalyste doit lui-même être psychanalysé avant de commencer à faire la psychanalyse pour les patients.

(8:47 - 9:08)

Alors, les psychothérapies Q-tips, c'est-à-dire les anciennes, reposent sur ce qu'on appelle la libre association des idées. Donc, l'analyste est invité à ne rien en mettre. En général, le thérapeute ne parle pas beaucoup, il n'interprète pas beaucoup dans les premières cures, les cures anciennes.

(9:08 - 9:43)

Ce qu'on appelle la libre association des idées, c'est le fait que le patient commence à raconter. Donc, quand le thérapeute lui demande de raconter, bien sûr, il lui laisse le choix de raconter et de commencer son histoire là où il veut. Soit il peut commencer par l'enfance et venir à l'adolescence, à l'âge adulte, soit commencer par l'âge adulte et puis retourner à l'enfance, soit faire des va-et-vient entre l'enfance, l'âge adulte, l'âge où il est maintenant, et faire des va-et-vient ou bien suivre un ordre.

(9:43 - 10:07)

C'est la libre association des idées. On laisse le choix au patient de raconter son histoire comme il veut. Et bien sûr, à travers ça, à travers comment le thérapeute est posé, à travers comment il fait avec le patient, même s'il n'intervient pas beaucoup, mais c'est ça qui va lier cette relation thérapeutique.

(10:08 - 10:38)

Et ça peut créer des transferts. Donc il y a des patients qui peuvent faire des transferts, des identifications par rapport aux psychanalystes, et ça peut aller plus loin, par exemple, des femmes qui vont tomber amoureuses de leur psychanalyste. Alors l'ancien cure, vous voyez là, le patient est allongé sur un divan et le thérapeute est placé derrière le patient, bien sûr, pour garder ce qu'on appelle une neutralité bienveillante.

(10:38 - 10:58)

Si jamais le patient dit quelque chose, soit au niveau émotionnel, soit au niveau des affects, soit en rapport avec son histoire, ça ne doit pas s'ouvrir sur le visage du thérapeute. C'est pour ça que le thérapeute se met derrière le patient pour le mettre à l'aise. Ou bien à côté, là, il n'y a pas le face-à-face.

(10:59 - 11:22)

Donc les séances durent une demi-heure à trois quarts d'heure, deux à trois fois par semaine pendant quatre à six semaines, mais c'est en fonction des pathologies. Il y a des patients qui font des psychanalyses pendant des années, cinq ans ou plus. Donc les indications les plus fréquentes, c'est les états d'angoisse, les états d'inhibition, les troubles sexuels et même les états dépressifs.

(11:23 - 11:49)

Maintenant, ça s'est étalé à d'autres indications. Donc là, c'est juste pour avoir une idée. Si jamais un patient vous pose la question, comment ça se passe? Là maintenant, actuellement, on parle de psychothérapie d'inspiration analytique, c'est-à-dire les méthodes ne vont pas être les mêmes que dans la psychothérapie analytique cure-type ancienne.

(11:50 - 12:09)

Vous voyez, il y a un petit peu une différence par rapport aux méthodes. Par exemple, là, les psychanalyses, les entretiens, les thérapies psychanalytiques que vous voyez dans les films, le patient est assis en face du thérapeute. Donc les références théoriques sont les mêmes, c'est-à-dire il y a cette libre association.

(12:09 - 12:25)

Le thérapeute, il va demander au patient de commencer à raconter son histoire de là où il veut. Et il y a également l'utilisation de cette relation de transfert. Le thérapeute, c'est un psychanalyste et il est assis.

(12:25 - 12:40)

La différence, c'est qu'il est assis en face à face et il peut intervenir de temps en temps. Donc là, la participation du thérapeute, elle est beaucoup plus fréquente par rapport aux anciens psychanalyses. Donc les indications sont beaucoup plus larges.

(12:41 - 12:54)

Les névroses graves. Quand on parle de névrose, là, c'est un terme qu'on n'utilise plus, mais parce que là, on est devant la psychanalyse. C'est un terme qui a été utilisé et qui a été évoqué par Freud.

(12:54 - 13:08)

Freud, c'est le père de la psychanalyse. C'est pour ça que je l'ai noté ici. Mais les névroses graves, ça concerne tout ce qui est trouble de personnalité, tout ce qui est dépression, résistance grave, tout ce qui est trouble anxieux.

(13:09 - 13:22)

À la limite, c'est un trouble de personnalité. Alors la psychothérapie, c'est clair. Pour la psychanalyse, vous avez une idée comment ça se passe? Les psychothérapies de soutien, ça, c'est ce que vous faites.

(13:22 - 13:36)

Normalement, c'est ce que vous devez faire. Depuis que vous avez commencé, si je puis dire, les stages à l'hôpital. Depuis que vous avez commencé, c'était en troisième année, que vous avez été avec un patient.

(13:37 - 13:59)

La moindre des choses, le fait de passer devant le patient chaque jour, de venir voir votre patient chaque jour, lui dire bonjour, ça, c'est du soutien. Parce que ce patient-là, vous, vous ne vous rendez pas compte, mais ce patient-là, il est là depuis une semaine, depuis deux semaines, depuis un mois. Il peut même être en rupture par rapport à sa famille.

(14:00 - 14:11)

Peut-être qu'il n'attend que vous. Et quand vous venez, c'est un soutien, c'est un soulagement, c'est une amélioration de sa symptomatologie. Donc, c'est une technique la plus utilisée en pratique.

(14:12 - 14:28)

Vous l'utilisez de façon consciente ou bien de façon inconsciente. C'est votre savoir-être et votre savoir-faire. Ce n'est pas le savoir, le savoir, c'est les connaissances théoriques que vous avez reçues au cours de votre cursus.

(14:28 - 14:47)

Mais après, quand vous êtes devant le patient, c'est le savoir-être et le savoir, la manière avec laquelle vous posez les questions. Pas vous êtes pressé à faire le dossier pour trouver le diagnostic, pour donner le traitement, comme ça, après, le patient peut sortir. La manière avec laquelle vous posez les questions.

(14:48 - 15:02)

En même temps, quand vous avez des signes, vous essayez d'expliquer au patient pour le rassurer. Quand vous avez un diagnostic, vous essayez de rassurer le patient. La manière d'annoncer votre diagnostic.

(15:02 - 15:15)

Et bien sûr, la manière de le prendre en charge, la manière de le soigner si vous êtes un chirurgien, si vous êtes un médecin qui va faire des gestes. Ça aussi, ça compte. Donc, il n'y a pas de référence théorique.

(15:16 - 15:31)

C'est votre savoir-être, votre savoir-faire. Et c'est ça qui va faire la différence entre un bon médecin et, si je puis dire, entre guillemets, un mauvais médecin. Parce que les connaissances théoriques, vous pouvez tous les avoir.

(15:31 - 15:55)

Il y a un médecin qui a ce savoir-être et un médecin qui traite les malades juste pour un bénéfice, soit pour être payé, soit pour être remercié, soit pour autre chose. Donc, il se base sur l'écoute et l'interprétation prudentes d'un matériel conscient. Là, le patient, quand il va verbaliser sa souffrance, c'est quelque chose de conscient.

(15:55 - 16:06)

Et vous, vous devez être très attentif. Le patient doit le sentir, doit sentir que vous l'écoutez. Ce

n'est pas uniquement que vous l'entendez, mais que vous l'écoutez, une écoute active.

(16:06 - 16:21)

Il doit aussi sentir que vous êtes empathique avec lui. Ça, les patients le sentent. Des fois, le patient vient se plaindre pour dire « il ne me regardait même pas ». Moi, je parlais, lui, il écrivait.

(16:22 - 16:32)

Il ne me regardait même pas. Ou bien il ne réagissait même pas à des réponses par rapport à mes émotions négatives. Ou bien par rapport à des choses graves que j'ai dites.

(16:32 - 16:45)

Par exemple, quand vous allez poser la question « les parents, ils sont vivants ? » Non, ils sont tous les deux décédés alors que j'avais cinq ans. C'est un moment où vous devez vous arrêter quand même. Ce n'est pas un renseignement que vous allez avoir comme ça.

(16:46 - 17:17)

D'accord ? Donc, bien sûr, au cours de cette écoute, il va y avoir de la réassurance, de l'encouragement et des conseils entre guillemets. Les conseils, vous dites en fonction, de façon scientifique, en fonction de votre expérience, en fonction, vous êtes quand même un savant, en fonction de ce que vous avez vu, comme chez les autres patients, et bien sûr, en accord avec le patient. Moi, je pense qu'il faut faire ça, vous devez commencer par ça.

(17:17 - 17:41)

Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous dites si on essaie de faire ça au lieu de ça ? Si, par exemple, il vous dit oui, il vous donne une proposition, vous, vous trouvez que ce n'est pas la bonne, donc vous proposez la vôtre, mais on n'impose pas. Parce qu'après, le patient, si vous commencez à faire ça, il va attendre les conseils de vous. Il va attendre qu'il soit guidé dans tout ce qu'il fait.

(17:42 - 18:22)

Alors, le but, ça aide à améliorer les symptômes et une meilleure adaptation du sujet à sa maladie, des fois, si on n'arrive pas à guérir, et une meilleure adaptation au thérapeutique. Il va s'adapter à la chimiothérapie, il va s'adapter à une amputation, il va s'adapter à un traitement chronique, un traitement à vie. Donc, vous pouvez aussi, au cours du soutien, par exemple, un patient qui a, c'est surtout les adolescents, qui a un problème de communication avec les parents ou bien avec son frère, il va vous demander de l'aide pour l'aider à améliorer sa relation avec son entourage.

(18:22 - 18:55)

Ça, c'est du soutien que vous pouvez faire de plus, ou bien améliorer les conditions professionnelles du patient, lui donner des conseils, comment il va gérer le stress au sein de son milieu de travail, ou bien comment il peut gérer les conflits au sein de son milieu de travail. Les indications, il n'y a pas d'indication précise. Toutes les pathologies, on ne parle pas uniquement de la psychiatrie, toutes les pathologies, surtout graves, les cancéreux, les diabétiques, alors après vient la psychothérapie cognitivo-comportementale.

(18:56 - 19:14)

Alors ici, la psychothérapie, elle agit ici sur le symptôme et non pas sur la personnalité. On va modifier le symptôme. Donc, c'est un déconditionnement d'un sujet pour transformer un comportement pathologique acquis ou une conduite adaptée.

(19:14 - 19:28)

On va prendre comme exemple, pour comprendre cette thérapie, c'est les troubles anxieux. On peut la faire dans la dépression, on peut la faire dans les addictions. L'exemple où ça se voit de façon plus claire, c'est les troubles anxieux.

(19:29 - 19:56)

Un patient, par exemple, qui a un TOC, un trouble obsessionnel-compulsif, vous avez terminé les troubles anxieux, c'est ça ? Le TOC, donnez-moi un exemple de TOC. Laver les mains. Un patient qui lave les mains, et vous savez, les patients qui ont des TOC, ce ne sont pas des comportements qui sont à une fréquence deux, trois fois par jour.

(19:56 - 20:06)

Ça, deux, trois fois par jour, c'est vous. Ça vous arrive de vous laver les mains une fois, après vous dites non, ce n'est pas bien lavé, vous refaites deux, trois fois. La porte une fois, après vous vérifiez deux, trois fois.

(20:06 - 20:37)

Là, les TOC, c'est des centaines de fois. Il peut même s'attarder toute la matinée rien qu'à laver les mains, avant de passer à autre chose, et au point de ne plus pouvoir aller au travail. Donc si on parle de ce comportement, est-ce que les sujets sont nés sur le plan génétique avec ce comportement ? C'est un comportement qui arrive à un âge, ça peut arriver vers sept ans, vers dix ans, vers dix ans, mais avant, il n'avait pas ce comportement.

(20:38 - 20:52)

Donc c'est un comportement qui est acquis. Ce qu'il faut expliquer aux patients, dans la thérapie

de soutien, c'est tout comportement acquis, on peut le changer. Ce qu'on ne change pas, c'est le comportement inné, qui est dans les gènes.

(20:52 - 21:02)

Mais tout ce qui est acquis, on peut le changer. Par exemple, le comportement inné dans les bizarreries de comportement, dans la patience schizophrène. Mais ici, c'est un comportement qui est acquis, on va le changer.

(21:03 - 21:31)

Comment on va le changer ? Par la technique cognitive et comportementale. Cognitive, ces gens-là, ils ont des pensées erronées, et ils sont conscients de leurs pensées erronées. Le fait de laver la main, quelle est la pensée derrière ? Pourquoi il lave les mains une centaine de fois ? Quelle est la pensée obsessionnelle derrière ? Laver les mains, c'est la compulsion.

(21:32 - 21:50)

Quelle est l'idée obsessionnelle derrière ? Oui, la propreté, c'est le comportement de se laver les mains. Mais quelle est l'idée obsessionnelle ? Pourquoi il se lave les mains cent fois ? Les germes, c'est l'idée obsessionnelle. L'obsession, c'est qu'il y a des microbes.

(21:51 - 22:10)

Alors, est-ce que les microbes, on les voit à l'œil nu ? Non. Donc, pour qu'il les voie, il doit mettre un microscope. Est-ce que toute la population lave les mains une centaine de fois ? Non.

(22:11 - 22:47)

Donc, c'est juste chez lui et d'autres catégories. Est-ce que les autres sont atteints d'intoxication ? Donc, c'est ça, on va aller avec lui, on va traiter ses cognitions, s'analyser, essayer de trouver la logique dans ce qu'il pense. Est-ce qu'avant, quand il mangeait sans laver les mains cent fois, il a eu des intoxications ? Est-ce que quand on sort à l'extérieur, on ne prend pas, par exemple, quand on mange des sandwiches, des fois, est-ce qu'on lave les mains cent fois ? Est-ce que pour autant, on a des intoxications ? Non.

(22:47 - 23:17)

Donc, essayer de le raisonner sur le plan cognitif. Sur le plan comportemental, on fait ce qu'on appelle l'exposition aux situations anxiogènes, de sorte à le déconditionner ou bien à le désensibiliser par une exposition graduée. Où est-ce que vous avez vu cette désensibilisation ? C'est dans quelle pathologie ? Où on fait la désensibilisation ? Le ? Non, on ne parle pas de psychiatrie.

(23:17 - 23:30)

Oui, on fait l'allergie, exactement. L'allergie, qu'est-ce que vous lui donnez ? Le produit allergène. Et c'est par question d'habitude, comme si vous voulez, il va s'habituer.

(23:31 - 23:39)

C'est ce qu'on va faire aux patients. On va l'exposer. Au début, on va l'exposer de façon graduelle.

(23:39 - 23:50)

C'est-à-dire, il va, par exemple, parce que les gens qui se lavent, ils vont se laver avec de l'eau, avec du savon, avec de l'eau de Javel. Ils peuvent aller jusqu'à même avec de la selle. Donc, ils vont aller plus loin.

(23:50 - 24:01)

On va leur demander, par exemple, s'ils se lavent 100 fois. Il va aller de façon graduelle. La première semaine, se laver 100 fois avec tous les produits.

(24:02 - 24:11)

La deuxième semaine, essayez de se laver que 90 fois avec tous les produits. La troisième semaine, 70 fois. La quatrième semaine, avec tous les produits.

(24:12 - 24:29)

On peut, à un moment, négocier avec le patient. Est-ce que cette fois, vous pouvez vous laver 50 fois, mais enlever l'eau de Javel? Il va vous dire non. L'eau de Javel, c'est l'étape que je ne dois pas laisser en premier.

(24:29 - 24:35)

Qu'est-ce que vous pouvez laisser en premier? Le savon. Oui, je peux, parce que l'eau, bien sûr, elle a besoin. Le savon, je peux enlever le savon.

(24:35 - 24:40)

Il y en a qui utilisent plusieurs types de savon. Je peux enlever le savon. D'accord, on va enlever le savon.

(24:41 - 24:50)

Après, on va passer 40 fois, 30 fois. Est-ce que vous pouvez utiliser l'eau de Javel? Combien vous l'utilisez par jour? Trois fois. Donc, à chaque lavage.

(24:50 - 25:05)

Est-ce qu'on peut sauter une étape? Et ainsi de suite. Ça, on le voit avec le patient et on voit avec lui. Quelle est la chose la moins angoissante avec laquelle on va commencer? D'accord? Et on va commencer progressivement.

(25:06 - 25:24)

Après, à la fin, quand il va faire toutes les étapes, on peut aller même vers ce qu'on appelle l'inhibition conditionnelle. C'est-à-dire qu'on va l'exposer, par exemple, toucher la table et on va l'empêcher de se laver. Il va rester avec ça.

(25:24 - 25:34)

C'est quelque chose que l'État ne supporte pas. Avec ça, toucher la table pour lui, là, il a touché des microbes, la saleté. Et on va lui demander, on va rester avec lui.

(25:34 - 25:48)

On va lui demander de ne pas se laver. On va rester avec lui jusqu'à ce que le niveau d'angoisse diminue. Après, il va sentir que tout s'est bien passé, qu'il n'a rien ressenti, que l'angoisse est là, complètement disparue.

(25:49 - 25:56)

Et ça, c'est un exercice qu'il va faire progressivement jusqu'à l'habituatation. C'est une question d'habitude. Il va s'habituer.

(25:57 - 26:02)

Bien sûr, on peut le faire en cabinet. Des exercices, on peut les faire en cabinet. Vous n'aurez pas le temps.

(26:02 - 26:10)

On peut le faire en hospitalisation. C'est rare qu'on hospitalise ses patients. Donc, on va les faire à l'aide d'un co-thérapeute à la maison.

(26:10 - 26:18)

Quelqu'un de la famille qui va essayer de l'accompagner. Une fois qu'il va se laver 50 fois, ça y est, arrête. Il va l'empêcher de continuer.

(26:19 - 26:23)

Une fois qu'il a utilisé le savon, ça y est, arrête. Tu n'utilises plus le Javel. Il va l'empêcher.

(26:24 - 26:43)

Il va rester avec lui jusqu'à ce que le niveau d'angoisse diminue. Si on prend par exemple quelqu'un qui a la peur de l'ascenseur, de prendre l'ascenseur, la phobie de l'ascenseur. Les gens qui ont cette phobie, ils ont la phobie même de passer devant des immeubles où on a des ascenseurs.

(26:44 - 27:00)

Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec eux aussi progressivement ? Au début, passez devant un immeuble où il y a l'ascenseur. Après, vous pouvez faire ça plusieurs fois. Une fois que vous sentez que ça y est, vous pouvez le faire de façon à l'aise, vous allez passer devant l'immeuble et vous rentrez.

(27:00 - 27:06)

Parce qu'il y a des patients qui n'osent même pas regarder l'ascenseur. Vous regardez l'ascenseur. Après, on va aller progressivement.

(27:06 - 27:13)

Vous allez devant l'ascenseur. Après, vous allez appeler l'ascenseur. Vous allez rester, ne pas monter.

(27:14 - 27:27)

Après, on va leur demander de rentrer et de sortir. Ils peuvent le faire seuls, ils peuvent le faire à des étapes différentes, accompagnés. Après, on va leur demander de monter et de sortir.

(27:28 - 27:34)

Premier étage. Après, demander de sortir au deuxième étage. On peut leur demander de le faire seul ou accompagné.

(27:35 - 27:49)

On voit ça avec eux en fonction de leur niveau d'angoisse. Qu'est-ce qui vous angoisse le moins ? On commence par ce qui l'angoisse le moins et on augmente l'intensité. On va vers ce qui l'angoisse le plus.

(27:50 - 28:10)

Ce qui l'angoisse le plus, par exemple, ça peut être monter au cinquième étage tout seul. Ce qui va l'angoisser le plus, carrément, monter, fermer, être enfermé dans l'ascenseur et à chaque fois que la porte s'ouvre, la fermer et rester à l'intérieur pendant un certain temps. D'accord ? Donc

ça, c'est l'exposition de façon graduelle.

(28:12 - 28:39)

Par rapport, là, j'ai parlé de la technique d'affirmation de soi, c'est par rapport aux patients addicts. Les patients addicts, on va le voir dans les psychothérapies des addictions, ce sont des patients qui ont du mal, quand ils sont arrivés à l'abstinence totale, ils ont du mal à dire non quand on leur propose un verre. On va faire avec eux aussi un jeu de rôle où on va les mettre dans des situations où on va leur proposer un verre.

(28:39 - 29:22)

On va essayer même d'aller jusqu'à les intimider à prendre le verre et les encourager à dire non. Ça, c'est des techniques aussi comportementales et ça rentre avec une technique d'affirmation de soi où le patient va pouvoir dire non sans avoir la peur de perdre l'autre personne. Les techniques cognitives, l'exemple est axé sur la prise de conscience par le patient de la façon de penser qui est fausse, qui est erronée, d'accord ? Qui n'est pas logique à travers certains événements de son existence.

(29:22 - 30:03)

Donc là, on va prendre l'exemple de la phobie sociale. Vous avez fait la phobie sociale. Alors, c'est quoi le problème chez les phobiques sociaux ? C'est des patients, si on peut dire, trop exigeants qui mettent la barre plus haute, qui ont peur de quoi ? Du jugement des autres et qui ont des pensées automatiques, c'est-à-dire des pensées qui viennent à l'esprit quand ils sont confrontés à un problème avec le milieu extérieur, ils viennent la première fois sans réfléchir, sans analyser, et ce sont des pensées qui sont tout le temps négatives.

(30:04 - 30:40)

Par exemple, un conférencier, vous, par exemple, vous êtes en train de présenter votre topo aux étudiants, quelqu'un qui a une phobie sociale et il voit deux étudiants en train de rigoler. Qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête, celui qui a une phobie sociale ? Il se moque de lui. Il est ennuyeux, d'accord ? Il se moque de lui, soit de son cours, soit de sa façon de parler, soit il se moque de sa façon de s'habiller.

(30:40 - 30:54)

Donc, il peut penser n'importe quoi et il va que dans le négatif. Quand il est en train de donner son exposé, ça, c'est la pensée qui vient au premier plan, sans réfléchir. On l'appelle la pensée automatique.

(30:55 - 31:38)

Mais après, quand elle est en thérapie, on va lui poser la question. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas d'autres hypothèses ? Quand deux personnes en face de vous sont en train de rigoler, est-ce qu'il n'y a pas d'autres hypothèses ? Qu'est-ce qu'il va répondre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, peut-être qu'ils ont pensé à quelque chose, ils sont en train de rigoler, peut-être qu'ils parlaient d'autre chose, d'accord ? Peut-être qu'ils ont vu, c'est vrai, en moi, quelque chose qui les a fait rigoler, qui les a pensé à faire rigoler, mais sans que ça soit négatif pour moi, d'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les pensées alternatives. C'est des choses qui nous arrivent à nous tous.

(31:39 - 33:24)

Là, maintenant, par exemple, moi, en train de donner le cours, je peux voir deux personnes en train de rigoler, ou bien je peux voir une personne qui est en train de dormir. Je peux avoir cette pensée négative qui vient, je peux, des fois, même ne pas me rendre compte, parce que j'ai pas une phobie sociale, donc, rapidement, elle est remplacée par une autre pensée, qui est, ils sont en train de rigoler par quelque chose, ils ont pensé à quelque chose, d'accord ? Alors, le sujet qui est la phobie sociale, on va faire avec lui des exercices, on va faire avec lui des jeux de rôle, de façon à ce que lui aussi doit avoir ce remplacement de pensée automatique par les pensées alternatives de façon très rapide, d'accord ? Donc, on fait avec lui des jeux de rôle. On l'amène, soit, je sais pas pour les étudiants qui sont de passage au service, vous avez vu l'hôpital de jour, on fait là-bas des thérapies cognitives et comportementales, on peut inviter des patients qui ont des phobies sociales et inviter des externes, et on va demander aux patients phobiques de présenter quelque chose devant les externes, et on va demander aux externes de jouer le jeu, de le critiquer, de commencer à parler entre vous, de commencer à rigoler, d'accord ? Et lui, bien sûr, on a déjà travaillé avec lui, ce remplacement de pensée automatique par les pensées alternatives, et il va essayer de gérer ça devant vous, d'accord ? Imaginez que ça arrive, on a des professeurs d'université qui ont des phobies sociales, on a des notaires, on a des avocats, donc imaginez leur enthousiasme par rapport à leur travail.

(33:26 - 34:15)

Alors, les techniques comportementales et cognitives, ce sont des techniques directives. Pourquoi directives ? Pourquoi on dit directives ? Parce que vous donnez des directives aux patients, à la différence des thérapies psychanalytiques, ça je pose souvent cette question, les thérapies psychanalytiques ne sont pas directives, le thérapeute ne donne pas de directives aux patients, il lui demande, allez-y, parlez-moi, racontez-moi, c'est tout, et le patient commence à raconter, alors que ici, vous donnez des exercices, faites ça, faites ça, faites ça, vous analysez avec le patient ses cognitions. Alors l'indication, comme on a dit, elle est large, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles addictifs aussi.

(34:17 - 35:12)

Alors la relaxation, les thérapies à médiation corporelle, ce sont des thérapies qui vont utiliser le

corps, vous connaissez les techniques de relaxation, ce sont les techniques les plus pratiquées, donc elles consistent à l'apprentissage de la détente neuromusculaire, puis son contrôle, il y a une décontraction neuromusculaire qui aboutit à un tonus de repos basé d'une détente physique et psychique. Donc quand il y a une tension psychique, ça entraîne une tension physique, et là, on essaie de faire le contraire, on va procéder par la détente physique pour aboutir à une détente psychique. Donc elle est utilisée aussi dans les troubles anxieux, dans les affections psychosomatiques et dans les symptômes fonctionnels, les polyopathies fonctionnelles, les troubles fonctionnels.

(35:13 - 35:48)

Bien sûr, les contre-indications parce qu'on va utiliser décontraction et décontraction, c'est les états de dépersonnalisation où le sujet a une pensée qui est centrée sur son corps, ou bien les états de morcellement schizophrénique, donc aussi le sujet a l'impression que son corps est découpé en morceaux. Donc vous ne pouvez pas lui dire de contracter la main, de contracter le bras, ça va l'angoisser. Les troubles moteurs organiques, s'il a un trouble moteur, vous ne pouvez pas faire des contractions.

(35:48 - 36:43)

Les détentes aussi articulaires parce qu'on fait des contractions de l'avant-bras sur le bras et ainsi de suite, du poignet, on fait aussi le membre inférieur. Alors voilà à la base, comme je vous ai dit, quand il y a une contraction, une atteinte psychique, ça entraîne une contraction musculaire, donc le but de la relaxation, c'est d'aller dans le sens inverse, relâcher tout ce qui est musculaire, tout ce qui est physique pour avoir un relâchement et une accalmie de l'émotion psychique. Alors les techniques de relaxation de Jacobson, Jacobson, c'est lui qui a découvert la relaxation musculaire, elle définit la relaxation comme l'absence de toute contraction musculaire.

(36:44 - 37:34)

Le but est d'obtenir un calme dans le domaine psychique, comme on a dit, mettre au repos le cortex cérébral en relaxant le physique, ça donne une relaxation psychique. Et puis il y a aussi l'objectif de que le patient se rende compte après, quand vous faites une contraction de la main, vous vous rendez compte de cette tension, et quand vous relâchez, là vous vous rendez compte d'un apaisement, là vous vous rendez compte du bien de la relaxation, vous faites la différence entre les deux sensations. Contraction, vous pouvez l'essayer quand vous faites la contraction, ça vous fait mal un petit peu, vous n'êtes pas à l'aise, mais quand vous relâchez, là vous sentez ce relâchement, ce bien-être après le relâchement.

(37:34 - 37:56)

Et ça c'est des gens qui n'arrivent pas, il y a des gens qui n'arrivent pas à sentir le bien-être, qui n'arrivent pas à sentir cet apaisement, au biais qu'ils ne savourent pas l'apaisement. Mais quand

ils font la différence, c'est là où ils vont se rendre compte. Comme si vous voulez quelqu'un qui vit dans le bonheur total, il n'a jamais eu de malheur dans sa vie, il ne va pas le savourer.

(37:56 - 38:15)

Mais une fois qu'il y a un malheur, il va se rendre compte qu'il vivait dans le bonheur et il va le savourer. Alors ça c'est l'objectif. Alors l'hypnothérapie, je ne suis pas hypnothérapeute, je connais le principe.

(38:15 - 38:47)

Donc c'est un sommeil incomplet, parce que le sujet reste quand même en contact avec la réalité, parce qu'on va lui suggérer de faire quelque chose et il va le faire. Donc il est provoqué artificiellement et pendant lequel divers phénomènes peuvent apparaître spontanément ou en réponse à un stimulus. Donc le sujet en hypnose, il peut présenter des choses verbalisées, il peut parler, il peut présenter des choses de façon inconsciente.

(38:47 - 39:08)

Donc il va commencer à parler, il va commencer par exemple à évoquer des souvenirs, à parler des choses qu'il a cachées dans son inconscient ou bien en réponse à un stimulus. Le sujet, le thérapeute peut lui suggérer de faire des choses ou bien de répondre à des questions et il va répondre. Il facilite la suggestion et la libération des émotions.

(39:09 - 39:43)

Il est indiqué aussi surtout dans les symptômes de conversion. Les symptômes de conversion, c'est ce qu'on appelait avant les crises d'hystérie dans les manifestations somatiques, les troubles anxieux et dans les troubles sexuels et aussi dans les addictions. Alors il y a des techniques, vous allez voir quand vous allez sur Internet, il y a des techniques soit par des paroles que le thérapeute va, un discours que le thérapeute va dire au patient et lui, le patient va l'écouter et bien sûr, il ne faut pas résister, il faut jouer le jeu.

(39:43 - 40:55)

Quand vous voulez faire cette, si vous voulez être hypnotisé, on joue le jeu, on ne fait pas, on ne reste pas éveillé, on ne fait pas attention et on ne reste pas actif. Soit par des choses que le patient va demander à son, le thérapeute va demander à son patient de faire, on va voir là par exemple, vous pouvez fermer les yeux, essayez de voir, laissez-vous aller, on va profiter du moment pour un petit peu vous détresser, fermez les yeux, vous êtes bien, tranquille, vous respirez profondément, tranquillement, tous vos muscles se détendent, vos paupières sont lourdes, vous les fermez, vous sentez une agréable sensation de lourdeur vous envahir, vous êtes merveilleusement bien, vous glissez lentement irrésistiblement dans un sommeil réparateur. Réveillez-vous, ça fait du bien, ça fait du bien.

(40:56 - 41:52)

Est-ce que vous le faites, je ne parle pas de l'hypnothérapie, je parle de la relaxation, est-ce que vous faites des moments de relaxation comme ça, vous êtes chez vous, vous pouvez faire un discours qui va vous suggérer à faire des choses comme ça, ou bien va vous demander, relaxez-vous, ne pensez à rien, sentez votre pied, sentez où il est posé, sentez par exemple, votre chaise, vos mains, comment elles sont posées, ça, cinq minutes, vous allez vous sentir. Déjà maintenant, pas mentir, D'accord? Donc ça, vous le faites chez vous de temps en temps, cinq minutes, ça ne vous prend pas beaucoup de choses, mais ça déstresse, surtout à l'approche de l'examen. Là, c'est une autre technique, c'est une technique de confusion.

(41:52 - 42:28)

Le thérapeute, par exemple, va demander au patient de penser à son pied droit, puis très vite, pensez à votre main gauche, pensez à la couleur des yeux de votre père, pensez à ça, pensez à ça, pensez à ça. Donc le fait que votre esprit va faire des va-et-vient, de façon inconsciente, l'esprit va se sentir surchargé, il va chercher à se libérer de cette surcharge, et où il va pour se libérer de cette surcharge, il va se réfugier dans le sommeil. Donc c'est ça, les techniques.

(42:29 - 43:42)

Alors, les psychothérapies de groupe, bien sûr, reposent sur les phénomènes dynamiques, c'est-à-dire, quand il y a un groupe, il y a une interaction entre les différents membres du groupe, il y a des groupes de discussions entre les relations interpersonnelles, discussions de conflits, les groupes d'affirmation de soi, comme dans la phobie sociale, les sujets, quand il sent, par exemple, un conférencier en train de faire sa conférence, il faut qu'on travaille avec lui l'affirmation de soi, il doit avoir une affirmation de soi pour pouvoir avoir cette pensée alternative directement. Vous rigolez, non, je m'affirme, je sais ce que je vaudrais, je sais ce que je dis, donc il ne va pas mettre la barre plus haute, je leur donne quand même des choses qu'ils ne savent pas, donc il va pouvoir s'affirmer. Et il y a aussi dans les thérapies, comme je vous l'ai dit, on le fait aussi en collectif sous forme de jeu de rôle, ou bien on peut le faire sous forme de jeu de rôle entre les patients eux-mêmes, les patients qui ont des phobies sociales, ils peuvent le faire entre eux.

(43:42 - 44:14)

Les psychodrames, c'est des jeux de théâtre que les patients peuvent faire pour verbaliser des choses qu'ils n'arrivent pas à verbaliser dans un entretien normal. Alors les psychothérapies familiales, donc elles permettent d'améliorer la communication au sein de la famille, et ça on le trouve surtout par rapport aux problèmes chez les adolescents. Là, le thérapeute, au cours de cette thérapie, il va préciser le rôle de chacun d'un membre de la famille.

(44:14 - 44:52)

Bien sûr, ils sont indiqués dans la schizophrénie, les anorexies mentales, parce que l'anorexie mentale, le plus souvent c'est un problème de communication, un problème de verbalisation des émotions, et un problème du fait que les patients ne trouvent pas un milieu où ils peuvent s'exprimer. Donc quand on le fait dans le groupe avec un thérapeute et avec les gens concernés, là il a cette liberté de s'exprimer. Dans les addictions, c'est le groupe de parole, dans les addictions, et on peut faire aussi les thérapies cognitivo-comportementales en groupe dans les addictions.

(44:54 - 45:56)

Les thérapies de couple, ça c'est dans les problèmes conjugaux, donc on fait des thérapies, surtout quand il y a des problèmes, pas uniquement des problèmes sexuels, mais des problèmes de conflits, des couples qui vont arriver au divorce, par exemple, et ça on le voit de plus en plus, et même des fois maintenant, c'est les avocats qui le demandent, avant d'arriver au divorce, ils vont suggérer, conseiller aux parents d'aller voir un thérapeute pour une thérapie de couple. C'est bien de passer par là. Les thérapies institutionnelles, on en a parlé, c'est des thérapies où on voit les problèmes du personnel par rapport à leur vécu par rapport aux patients, et aussi où on peut faire des activités institutionnelles, des activités d'ergothérapie, c'est tout ce qui concerne des activités manuelles des patients, la poterie, la peinture, la couture, par exemple, ou bien des réunions personnelles, ou bien des réunions de patients dans des groupes de parole.

(45:56 - 46:22)

Ça s'appelle des thérapies institutionnelles. La sociothérapie, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est sensibilisation, démystifier la pathologie mentale, la resocialisation des malades mentaux, ou bien trouver un travail, intégrer un travail pour un malade mental ou bien pour un malade qui a une pathologie handicapante. Alors, je l'avais mis ici.

(46:23 - 47:27)

Comme je vous ai dit la dernière fois, le traitement des addictions, on va le voir avec le cours de... Alors, il y a ce qu'on appelle... Donc, on va voir d'abord les phases de début. Donc, avant de commencer la thérapie, bien sûr, quand vous faites l'entretien addictologique, vous avez terminé votre entretien, vous allez essayer d'informer le patient, essayer de le sensibiliser et de le motiver. Alors, on ne peut pas dire que la passion n'est pas motivée, ou qu'on n'a pas la volonté.

(47:27 - 47:33)

Si on a la volonté, on agit. Si on est motivé, on agit. Il ne va jamais revenir.

(47:34 - 47:50)

La motivation, la volonté, il est venu chez vous pour lui donner cette motivation et cette volonté. Il va vous dire, oui, docteur, je sais bien, je n'ai pas la volonté, je n'ai pas la motivation, motivez-moi, donnez-moi cette volonté, montrez-moi comment faire. Donc, c'est à vous de le faire.

(47:51 - 48:11)

Donc, après, initialement, il y a ces trois procédés, l'information, la sensibilisation et la motivation. Bien sûr, avec l'accord du patient, on l'informe s'il est d'accord, on le sensibilise s'il est d'accord. La motivation, bien sûr, s'il est d'accord, mais on va voir les différents stades.

(48:12 - 48:31)

Après, quand il va arriver au sevrage, il y a l'accompagnement pour éviter surtout la récurrence. Et après, à long terme, le challenge, c'est d'éviter les rechutes. Bien sûr, traiter les comorbidités qui peuvent entraîner les rechutes.

(48:31 - 49:20)

Un patient qui est addict à l'alcool parce qu'il était déprimé, parce que ça le soulageait, après, il faut traiter la dépression. Intégration des traitements... Moi, j'aimerais surtout rebondir sur les psychosociales. Est-ce que vous, quand vous recevez des patients jeunes, c'est un petit peu difficile, est-ce que systématiquement, est-ce que vous allez appeler les psychiatres? Et dans le cas où vous les appelez, est-ce que les patients sont adhérents à ce genre d'intervention? Il me parle à moi? Il a posé une question pour la psychiatrie.

(49:30 - 49:49)

Alors, après, il y a la réhabilitation psychosociale. Un patient alcoolique, peut-être qu'il a été licencié, il a été rejeté par sa famille, donc il faut la réinsertion de ce patient, l'aider à trouver un travail. Les patients alcooliques, peut-être qu'il a été licencié, les patients qui sont addicts à l'héroïne, qui sont addicts à la cocaïne, ce sont des patients qui peuvent être rejetés.

(49:49 - 50:05)

Les patients qui sont addicts à la colle synthétique, par exemple, rejetés par la société, donc il faut essayer de les réintégrer. Pendant toutes les phases, vous allez intervenir. On ne sort jamais définitivement d'une addiction.

(50:06 - 50:29)

Un patient peut être addict pendant 20 ans, et il peut rechuter. Alors, pour les thérapies motivationnelles, on va suivre ces étapes, comme on a dit, donc information objective et non biaisée sur l'état de santé et l'association personnelle. Bien sûr, on fonctionne avec l'accord du patient.

(50:29 - 50:51)

On va lui demander s'il veut connaître les informations sur sa santé, ou bien s'il veut connaître des informations sur l'effet des drogues sur la santé. Alors, s'il vous dit oui, bien sûr, là, vous pouvez commencer. Et bien sûr, s'il vous dit non, vous ne le donnez pas.

(50:52 - 51:10)

Et à la fin, vous pouvez donner des brochures, vous pouvez lui donner des sites internet où il peut consulter à tête reposée toutes les conséquences. Et vous donnez les informations de façon scientifique et de façon objective et non biaisée. Vous n'allez pas donner une information fausse pour faire peur au patient.

(51:11 - 51:25)

Ça donne des cancers alors que ça ne donne pas des cancers. Parce qu'après, il ne va plus vous croire, il ne va plus revenir. La responsabilité rappelée de la liberté de choix et d'action.

(51:26 - 51:45)

Cette passion de choisir, le choix d'arrêter, le choix de commencer par cette étape ou bien par l'autre étape, le choix de commencer par cette façon ou l'autre façon doit venir du patient. On n'impose pas. Quand vous essayez d'imposer un changement, au contraire, ça va faire fuir le patient.

(51:45 - 52:05)

Vous-même, quand vous êtes habitué à un comportement pendant des années et on va vous demander de le changer, on va vous obliger à le changer, dès qu'on n'est pas là, vous allez revenir à votre comportement. Donc, le changement doit venir du patient. Et ça, on lui dit qu'il a la liberté de choix.

(52:06 - 52:45)

Rien que les patients à dire de quoi ils ont peur, qu'on leur prive de leur liberté. Quand vous leur dites, vous avez la liberté de choix, quand est-ce que vous voulez commencer, avec quoi vous voulez commencer, comment vous voulez commencer, et même le thérapeute, choisir le thérapeute que vous voulez et où vous voulez commencer. Avis ou conseils, uniquement à la demande du patient et de manière professionnelle et non agressive, bien sûr, s'il vous demande un avis ou bien vous donner des conseils à sa demande, possibilité de traitement présentée au patient, on vous donne toutes les possibilités de traitement qu'il y a. Donc, s'il n'y a pas de traitement, vous dites qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de traitement miracle.

(52:45 - 53:00)

Tous les traitements pour le cannabis, c'est des traitements symptomatiques pour éviter les signes de sevrage. Il n'y a pas de traitement miracle, parce que les patients, les familles surtout, quand ils vous amènent un patient addict, c'est pour lui donner un traitement. Ça n'existe pas, un traitement.

(53:00 - 53:17)

Il y a des traitements en cours d'études, ça aussi vous le dites au patient. Condition nécessaire de l'entretien, l'empathie. Un patient que vous allez travailler avec lui, le sevrage, il faut être empathique avec lui, c'est quelque chose, c'est un grand pas, c'est un sacrifice.

(53:19 - 53:31)

Imaginez rien que le tabac. Pendant le ramadan, c'est un sacrifice, c'est quelque chose de grandiose. Et on vient au sentiment d'efficacité renforcée avant le sevrage et surtout à long terme.

(53:32 - 53:56)

Renforcer l'efficacité personnelle, c'est-à-dire à chaque fois qu'il fait un pas, encourager. À chaque fois, si jamais il vous a apporté une expérience de sevrage dans le passé, même d'une matinée, même d'une heure, quelqu'un qui consomme le tabac, il n'arrête pas les cigarettes. Cigarette, cigarette.

(53:57 - 54:09)

Même des fois, s'il a arrêté une heure, c'est un exploit. Le patient qui a arrêté pendant une semaine, c'est un exploit. Le patient qui a arrêté pendant une semaine, c'est un exploit.

(54:09 - 54:19)

Le patient qui a arrêté pendant le mois de ramadan, tout le mois, c'est un exploit. Encourager l'efficacité personnelle. Et vous dites au patient, rappelez-vous cette expérience.

(54:20 - 54:33)

À chaque fois que vous êtes devant la tentation, rappelez-vous cette expérience. À chaque fois que vous êtes devant la difficulté d'arrêter, le grieving psychique, rappelez-vous cette expérience. Comme quoi j'ai réussi, je vais réussir.

(54:34 - 54:40)

J'ai réussi, et tout s'est bien passé. À l'égal, le mois de ramadan, vous avez arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien.

(54:41 - 55:00)

Seulement dans la tête des patients alcooliques, quand ils arrêtent le mois de ramadan, ils gardent cette pensée comme quoi après le ramadan, ils vont consommer. Après, il y a ce qu'on appelle l'entretien motivationné. C'est un entretien au cours duquel vous allez motiver le patient.

(55:00 - 55:17)

Il se base sur deux techniques, deux modèles. La balance décisionnelle, c'est une balance, une feuille blanche que le patient va partager soit en deux, soit en quatre, où il va mettre les avantages et les inconvénients de la consommation. Ça, c'est quelque chose qui va laisser le patient réfléchir.

(55:18 - 55:38)

Et puis, il y a le stade de changement de Prochazka et de Clemente. Alors, on va voir. Donc, les deux techniques, elles permettent au patient de la mise en conscience de leurs distorsions cognitives, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas vivre sans consommation.

(55:39 - 55:55)

La consommation est la seule chose qui lui donne du plaisir. C'est mon anniversaire, il n'y a pas de mal, je ne vais consommer qu'aujourd'hui. Je fais la fête, ça fait un mois, deux mois que je n'ai pas consommé, j'ai droit à une récompense.

(55:56 - 56:10)

Ça, c'est des distorsions cognitives qui permettent, qui donnent l'autorisation au patient de consommer. Donc, ça, ces cognitions-là, on les travaille avec le patient. Alors, ça, c'est un exemple de balance décisionnelle.

(56:11 - 56:41)

Comme vous voyez ici, il y a les avantages à fumer, les désavantages à fumer, les avantages à arrêter, les inconvénients à arrêter. Par exemple, ça, vous allez la donner au patient pour qu'il la remplisse et vous la travaillez avec lui la séance prochaine. Au début, vous allez voir pratiquement les deux colonnes en bas sont vides, ou bien une chose ici.

(56:42 - 57:03)

Mais les deux premières colonnes, avantages à fumer, inconvénients, désavantages à fumer, pardon, les deux avantages à fumer et désavantages à arrêter. Là, les deux colonnes vont être remplies. Les inconvénients à fumer et les inconvénients à arrêter peuvent être vides.

(57:03 - 57:23)

Après, progressivement, avec la thérapie, vous pouvez voir que les choses vont s'inverser. Donc, même si le patient vous dit non, il n'y a pas d'inconvénients, non, je ne vais pas la remplir, vous lui dites réfléchissez chez vous. Vous lui donnez et vous lui dites de réfléchir chez lui.

(57:23 - 57:34)

Après, une fois qu'il va la ramener, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Ça me calme. Donc, le problème, c'est le problème 2, vous n'êtes pas calme et vous cherchez.

(57:34 - 57:46)

Pourquoi vous n'êtes pas calme? Ça me détend. Donc, le problème, vous êtes en tension, vous n'êtes pas détendu. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une autre alternative? Vous voyez avec lui, l'autre alternative.

(57:46 - 57:51)

Tout ça, vous pouvez travailler. Ça me coûte cher. Ça vous coûte cher.

(57:51 - 58:00)

Combien ça vous coûte? Très bien. Donc, l'argent qui vous coûte par mois, combien? Je dis n'importe quoi. Ça peut me coûter 500 dirhams par mois.

(58:01 - 58:09)

Avec ces 500 dirhams, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et on va travailler avec lui, ça. Là, il se rend compte. Parce que tout seul, il ne se rend pas compte.

(58:09 - 58:18)

Je deviens irritable, agressive. Ça, on peut le corriger. Vous lui expliquez déjà pourquoi il devient irritable, agressive.

(58:19 - 58:35)

Parce que la drogue, elle le rend irritable et agressive. Et parce que le fait d'être irritable et agressive après des signes de sevrage, c'est quelque chose qui a une durée. On a vu les durées par rapport à chaque consommation.

(58:36 - 58:46)

Par exemple, pour le cannabis, vous lui dites ça ne va pas dépasser deux semaines. Si on arrive à dépasser ce cap, alors tout va rentrer dans l'ordre. On ne va plus parler de cette agressivité.

(58:47 - 58:55)

Et ainsi de suite. Donc ça, c'est une chose que vous allez travailler avec lui. Vous lui donnez l'exercice à faire à la maison et vous le discutez avec lui.

(58:56 - 59:12)

Alors, les stades par lesquels le sujet passe dans sa pensée et son comportement, c'est ce qu'on appelle les stades théoriques du changement. Le premier stade, c'est l'indétermination. Il n'est pas du tout déterminé à arrêter.

(59:12 - 59:22)

Là, il ne va pas venir. Et même quand il vient, il va vous dire je ne vais pas arrêter. Pourquoi vous voulez que j'arrête? Moi, je suis bien avec la substance.

(59:22 - 59:39)

Je suis bien avec le cannabis. Je ne dérange personne. En quoi ça dérange les autres? Je me réveille, je prends ma douche, je fume mon joint, je vais au travail, je vais à mes études, je rentre, je fume encore un autre joint.

(59:40 - 59:45)

Le soir, je peux fumer trois ou quatre joints. En quoi ça vous dérange? Ça ne dérange personne. Moi, je me sens bien.

(59:46 - 59:54)

Je bois de l'alcool, ça ne me dérange pas moi. Je veux bien prendre un verre, deux verres, trois verres, quatre verres par jour. Je veux bien faire la fête le week-end avec mes copains.

(59:54 - 1:00:14)

En quoi ça dérange? Je me sens bien, ça me fait plaisir. Ça ne le dérange pas lui peut-être, mais ça dérange la famille. Donc là, le challenge durant cette phase-là, c'est quoi? C'est quoi votre défi? La première consultation, quand le patient, il vous dit, je n'ai pas de problème.

(1:00:14 - 1:00:37)

En quoi ça vous dérange que je consomme? Moi, ça me fait du plaisir. Quand vous voulez lui parler, vous essayez de faire quoi? La conscience du problème, c'est-à-dire semer le doute chez lui, mais le défi, c'est qu'il revienne la prochaine fois. Vous essayez de faire de sorte qu'il revienne la prochaine fois.

(1:00:39 - 1:00:48)

Alors l'intention, il a l'intention d'arrêter, mais il n'a pas encore vu tous les avantages. Il n'est pas encore convaincu. Là, il est déterminé d'arrêter.

(1:00:50 - 1:00:55)

Là, il est en action. Il a arrêté. Là, il est un petit peu à distance.

(1:00:55 - 1:01:03)

Il est en sevrage depuis des mois. Et vous voyez là, la rechute, elle fait partie du cycle. Ce n'est pas pathologique.

(1:01:04 - 1:01:20)

On s'attend à ce que le patient rechute. Mais ce n'est pas au début qu'on disait ça aux patients. Qu'est-ce que ça leur fait? Parce qu'au début, on disait aux patients, ne vous inquiétez pas, parce que la rechute fait partie du cycle.

(1:01:21 - 1:01:38)

On s'attend à ce qu'il y ait des rechutes. Qu'est-ce que ça fait aux patients? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ça encourage plus fort. Il est possible de rechuter.

(1:01:39 - 1:01:44)

Il peut le minimiser. Ça peut l'encourager. Il peut dire que j'ai droit.

(1:01:44 - 1:02:10)

De toute façon, le médecin me l'a dit. Après, on ne le dit plus de cette façon, mais on dit aux patients, parce qu'il y a des pratiques qu'on faisait avant, avec les théories, avec les moyens, les thérapies cognitives, comportementales, motivationnelles, on ne le fait plus. Avant, qu'est-ce qu'on disait aux patients? Quand je reçois un patient addict, je lui donne un traitement symptomatique.

(1:02:10 - 1:02:17)

Je lui dis, il ne faut plus consommer. Arrêtez de consommer. Si vous consommez, ne venez plus chez moi.

(1:02:18 - 1:02:35)

Je ne veux plus vous voir si vous consommez. Maintenant, on ne dit plus ça. Alors, même la façon de parler de la rechute, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, si jamais vous sentez que vous êtes tenté, venez avant pour qu'on discute, pour ne pas rechuter.

(1:02:36 - 1:02:52)

Et si jamais vous ne pouvez pas venir, sachez que je suis là. C'est-à-dire, même après la rechute, sachez que je suis là et qu'on va en parler. Ce n'est pas parce que des fois, les patients vont dire, ça y est, c'est foutu.

(1:02:53 - 1:02:59)

Ils vont tomber dans l'addiction. Ils vont rechuter de façon plus sévère. Il y a qu'ils rechutent de façon plus sévère.

(1:02:59 - 1:03:06)

J'ai fait des efforts, ça fait des années que je fais des efforts. Là, je suis en rechute, ça y est, c'est foutu. Ça ne sert à rien.

(1:03:07 - 1:03:12)

Mon médecin, de toute façon, va être fâché. Ma famille, je les ai déçus. Il va tomber de façon plus sévère.

(1:03:13 - 1:03:28)

Alors là, avec des exemples, l'indétermination, la personne n'a pas encore considéré son problème comme étant un problème ou alors elle le considère sans importance. Le cannabis ne me pose aucun problème. C'est ma mère qui trouve que je fume trop.

(1:03:29 - 1:03:37)

Ça pose un problème à ma mère. Et alors? C'est elle qui cherche les problèmes. Il n'y a qu'à ne pas fouiller dans mes affaires.

(1:03:39 - 1:04:02)

Alors, ici, quelle est votre action? Augmenter la conscience du problème et la possibilité de changer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux sans cannabis? Est-ce que vous ne pensez pas que votre maman va se calmer, que la relation avec votre maman va s'améliorer? Donner des prescriptions peut s'avérer contre-productif. On ne donne pas de traitement.

(1:04:03 - 1:04:11)

Là, on ne donne pas d'ordonnances. On peut lui donner des brochures, mais pas d'ordonnances. Des sites internet, pour qu'il cherche des informations, mais pas d'ordonnances.

(1:04:11 - 1:04:17)

L'intention, plus ou moins conscient. Il a l'intention. Et ça, ça arrive à plusieurs personnes.

(1:04:17 - 1:04:31)

Comme l'intention de maigrir. L'intention de jeter les vêtements que vous n'utilisez pas depuis des années dans votre armoire. D'accord? Et cette intention, elle peut rester pendant des années.

(1:04:32 - 1:04:40)

Quel est l'égoïsme? Moi, je vais arrêter un jour l'alcool. Je vais arrêter le tabac. Alors, la reconnaissance de l'existence du problème et de son importance.

(1:04:40 - 1:04:48)

Aller et venir entre les raisons pour changer et les raisons pour rester les mêmes. Là, il est ambivalent. Il veut arrêter.

(1:04:48 - 1:04:53)

Il ne veut pas arrêter. Il n'a pas encore trouvé tous les avantages. Il n'est pas encore sûr.

(1:04:54 - 1:05:04)

Là, qu'est-ce qu'il dit? Je me dis parfois qu'il faudrait que j'arrête le cannabis. Mais j'ai du mal à m'imaginer sans fumer. C'est la seule chose qui me fait vraiment plaisir.

(1:05:05 - 1:05:15)

Il veut arrêter parce qu'il a vu qu'il y a des problèmes, mais en même temps, il pense au plaisir. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette phase? Aider à trancher ce dilemme. Aider le patient à trancher.

(1:05:16 - 1:05:31)

La perception d'inconvénients dans la situation actuelle peut générer une envie de changement. Déjà, il a perçu des inconvénients par rapport au conflit qu'il a, par exemple, avec sa maman. C'est une motivation extrinsèque.

(1:05:33 - 1:05:43)

Et bien sûr, les avantages de la situation antérieure sont toujours présents. Donc, la situation antérieure, c'est la situation de consommer. L'avantage, c'est le plaisir.

(1:05:44 - 1:05:55)

Alors là, on va avec lui pour chercher la motivation intrinsèque. Parce que le changement doit venir de lui. C'est lui qui doit trouver l'intérêt à améliorer sa relation avec sa maman.

(1:05:56 - 1:06:09)

L'intérêt à arrêter. De trouver les choses positives que l'arrêt va lui amener. Gagner de l'argent, trouver sa concentration, retrouver son attention, s'améliorer dans ses études.

(1:06:10 - 1:06:20)

Ça va venir de lui. La détermination, c'est une fenêtre ouverte sur une action possible. Là, le patient planifie un changement.

(1:06:21 - 1:06:29)

Mais qu'est-ce qui se dit là? Là, je dois réellement faire quelque chose. Ce qui s'est passé dernièrement me fait vraiment peur. Il faut que j'arrête.

(1:06:29 - 1:06:41)

Donc là, c'est par rapport à un déclic qui est arrivé. Ça peut être une remarque de son petit enfant. Ça peut être un problème grave au cours de la conduite.

(1:06:42 - 1:06:51)

Il a failli, par exemple, tuer toute sa famille. Ça peut être un problème grave dans son travail. Il a oublié quelque chose, par exemple, un médecin, un chirurgien.

(1:06:52 - 1:07:00)

Donc là, c'est le déclic. Alors là, il est déterminé. Alors là, le conseil, bien sûr, on voit le besoin des patients.

(1:07:00 - 1:07:10)

Et c'est là qu'on commence à prendre des rendez-vous. Durant les deux premières phases, on cherche à ramener le patient, qu'il revienne. Là, on donne des ordonnances parce qu'il va arrêter.

(1:07:11 - 1:07:30)

On donne des ordonnances pour aider à traiter les symptômes de sevrage. Et bien sûr, un soutien psychologique et une réassurance. Le stade d'action, là, le patient dit qu'il est content d'avoir pu réduire sa consommation.

(1:07:30 - 1:07:50)

Je suis beaucoup mieux depuis que je ne fume plus. Là, il ne voit que les avantages. Il est content.

Il a du plaisir à arrêter. Il ne parle plus du plaisir de la consommation. Donc, à chaque fois, aider le patient à verbaliser les inconvénients et à verbaliser les difficultés.

(1:07:50 - 1:08:02)

Même s'il est en sevrage, il doit sûrement être en difficulté. En difficulté à dire son nom, par exemple. En difficulté à accepter des invitations, à recevoir des amis avec qui il consommait.

(1:08:03 - 1:08:10)

Donc là, il faut l'aider à verbaliser, renforcer son efficacité personnelle. Bravo, on est au dixième jour. Bravo.

(1:08:11 - 1:08:26)

Vous vous rappelez dans les films Les alcooliques anonymes ? Je suis alcoolique et je suis en sevrage depuis une année. Alors, bravo. Là, les groupes de parole servent aussi à s'encourager entre eux.

(1:08:27 - 1:08:44)

Aider le patient à verbaliser et à citer les difficultés et mettre des stratégies de gestion, des stratégies pour faire face aux difficultés. On peut le faire avec le patient. Là, la consolidation.

(1:08:45 - 1:09:18)

Donc, c'est encore difficile de ne plus consommer du cannabis, mais ça va de mieux en mieux. J'ai l'impression de commencer une nouvelle vie. Là, c'est après quelques mois ou bien quelques années, mais le risque, il est toujours là.

Toujours la même chose. Encourager à parler des difficultés et mettre les stratégies pour faire face. Le stade de rechute, je me suis dit juste un petit jour, et c'est comme ça que ça arrive.

C'est mon anniversaire. Je mérite une récompense. J'ai eu une promotion.

(1:09:18 - 1:09:22)

Je mérite une récompense. J'ai eu une promotion au travail. On a fait la fête pour moi.

(1:09:22 - 1:09:31)

On a fait le pot pour moi. C'est mal vu que je ne vois pas alors qu'ils ont fait ça pour moi. La vie était triste sans cannabis.

(1:09:31 - 1:09:39)

Là, c'est la nostalgie du plaisir dû au cannabis. Là, on recommence. Vous voyez dans le cercle, on va recommencer depuis le début.

(1:09:40 - 1:09:50)

Le travail, il est un petit peu difficile. Mais on a l'avantage comme quoi elle a fait l'expérience. C'est le renforcement par rapport aux expériences passées.

(1:09:51 - 1:10:03)

Ça, c'est les mêmes techniques. Dites autrement, qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque étape? C'est la même chose. La psychothérapie de soutien est faite par tout le monde.

(1:10:04 - 1:10:21)

Les spécialistes, les généralistes, les psychothérapeutes, les psychiatres. Pourquoi? Pour préparer une thérapie structurée pour le maintien de la compléance pour le renforcement de la motivation. Le patient addict a besoin de soutien.

(1:10:22 - 1:10:38)

La thérapie cognitivo- comportementale, on a dit qu'elle est essentielle dans les addictions. C'est surtout dans le groupe d'affirmation de soi, la gestion des émotions, la colère. Quelqu'un qui est en colère n'arrive pas à gérer ses émotions, il va aller vers la prise d'alcool, par exemple.

(1:10:40 - 1:10:56)

Quelqu'un qui n'ose pas dire non, il va accepter quand on lui offre un verre. Et ça aide aussi dans la prévention de la rechute. On a terminé pour les psychothérapies et la psychothérapie des addictions.

(1:11:00 - 1:11:04)

La prochaine fois, on va commencer les cours de pédopsychiatrie.